

BUKU SAKU KADER

**Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
bagi Balita Bermasalah Gizi**



BUKU SAKU KADER
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
bagi Balita Bermasalah Gizi

Kementerian Kesehatan RI
2025

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

362.12

Ind

B

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI

Buku Saku Kader: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
Bagi Balita Bermasalah Gizi. — Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2025.

107 hlm.; illus.

1. Judul

I. Community Health Workers

II. Health Promotion

III. Public Health

IV. Health Education

Buku Saku Kader
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
bagi Balita Bermasalah Gizi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Primer dan Komunitas
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jakarta, 2025

Pengarah:

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga

Penyusun:

Budi Ikhwansyah	Heny Purbaningsih	Sari Anggreani
C. Vita Aristyanita	Hikmah Kurniasari	Siti Masrurah
Dakhlan Choeron	Ira Nola Lingga	Wira Hartiti
Desi Agustini	Maya Rayyan	Widyawati
Dewi Astuti	Mursalim	Yessi Priskila
Endah Ramadhine	Nia Novita Wirawan	Yuni Zahraeni
Endang Achadi	Rina Agustina	
Esti Katherini Adi	Risang Rimbamatdja	

Editor:

Christopher Devin
Dewi Astuti
Maria Giovanie Anggasta
Meisya R. Profilita

Diterbitkan oleh:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dikeluarkan oleh:

Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang



Kemenkes

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Salam sehat Ibu dan Bapak Kader yang kami banggakan,

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat serta KaruniaNya sehingga tersusun "Buku Saku Kader dan Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi Balita Bermasalah Gizi" yang diharapkan dapat menjadi teman setia Ibu dan Bapak kader dalam pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal yang selanjutnya disebut PMT lokal.

PMT lokal bagi balita bermasalah gizi bertujuan untuk perbaikan gizi, menambah asupan gizi di luar konsumsi makanan sehari-hari. Tambahan asupan gizi yang diberikan melalui PMT lokal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi sehingga dapat terjadi kenaikan berat badan dan perbaikan status gizi.

Status gizi baik merupakan salah satu tanda pertumbuhan dan perkembangan optimal. Mari kita bersama-sama memastikan balita mempunyai status gizi baik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya karena balita merupakan generasi penerus bangsa.

Buku saku ini sebagai sumber informasi dan acuan bagi Ibu dan Bapak kader serta tim pelaksana kegiatan PMT lokal yang memuat informasi penting tentang:

- a. Cara mengenali balita bermasalah gizi sebagai sasaran PMT lokal
- b. Panduan pelaksanaan PMT lokal
- c. Cara memantau pertumbuhan dan keberhasilan PMT lokal
- d. Pesan-pesan gizi dan kesehatan yang perlu disampaikan kepada ibu/orang tua/pengasuh serta keluarga

Kader dan tim pelaksana lainnya sangat berperan dalam penyelenggaraan kegiatan PMT lokal dimulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan.

Kami sangat mengapresiasi atas bantuan, semangat dan kerja keras Ibu dan Bapak kader sebagai penggerak di masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi teman kerja kader.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga



dr. Lovely Daisy, MKM

Daftar Isi

07 Daftar Isi

09 Penggunaan Buku

12 Pendahuluan

25 Mengetahui Balita Bermasalah Gizi

37 PMT lokal bagi Balita Bermasalah Gizi

45 Kegiatan Kader dalam Pelaksanaan PMT lokal

77

**Contoh Menu dan Siklus Menu PMT
lokal bagi Balita Bermasalah Gizi**

82

**Edukasi oleh Kader bagi
Ibu/Orang Tua/Pengasuh**

90

**Cara Kader Berkomunikasi kepada
Ibu/Orang tua/Pengasuh**

97

**Pertanyaan dan Jawaban
yang Sering Muncul**

Perhatian



Buku ini sebagai acuan Kader dan Tim Pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan PMT lokal



Buku ini digunakan setiap saat setiap waktu dalam penyelenggaraan kegiatan PMT lokal



Kader selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan PMT lokal

Kurang gizi pada balita, **bisa bahaya lho!**

- a. Balita berat badan Tidak Naik atau T (tetap, turun, naik tidak cukup), bisa menjadi tanda balita berisiko masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, stunting)
- b. Kurang gizi pada anak usia 0–2 tahun dapat **menyebabkan hal serius** seperti:
 1. Risiko menjadi stunting, yaitu anak memiliki panjang/tinggi badan yang kurang dibandingkan panjang/tinggi badan yang seharusnya menurut usianya
 2. Risiko tidak cerdas
 3. Pada usia dewasa berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dll
 4. Ketika sakit, risiko kematian pada balita gizi buruk 12 kali lebih tinggi dibanding balita gizi baik

Oleh karena itu, Pastikan Berat Badan Balita selalu Naik Cukup setiap Bulannya ya!

Yang wajib dilakukan ibu/orang tua/ pengasuh antara lain:

- a. Pantau pertumbuhan rutin setiap bulan (**cek kenaikan berat badan**)
- b. Pastikan kebutuhan gizi terpenuhi (**makan makanan bergizi dan beragam kaya protein hewani dengan jumlah yang cukup**)
- c. **Segera ke Puskesmas**, temui tenaga kesehatan **jika sakit dan atau berat badan anak tidak naik (walaupun 1 kali)**



**Bakso Ayam
Isi Telur**

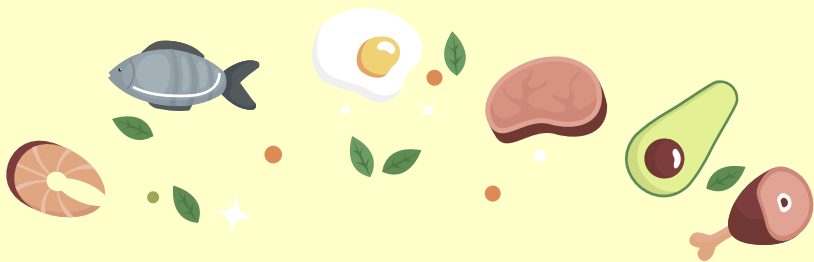


Tahu Isi Telur

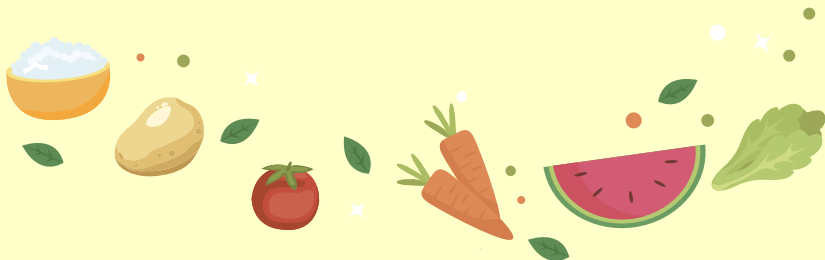
Balita bermasalah gizi (T, berat badan kurang dan gizi kurang) **harus mengonsumsi makanan tambahan untuk memperbaiki status gizi**, mencegah tidak jatuh pada masalah gizi yang lebih berat (gizi buruk dengan atau tanpa stunting).

Jika balita bermasalah gizi tidak mengonsumsi makanan tambahan sesuai rekomendasi maka **berisiko besar menjadi balita gizi buruk dengan atau tanpa stunting**.





PENDAHULUAN



Penyebab Masalah Gizi

Modifikasi Kerangka Kosep UNICEF (Conceptual Framework of Malnutrition, 1990)



● Penyebab langsung ● Penyebab tidak langsung ● Penyebab yang mendasari

- Masalah gizi pada anak disebabkan oleh berbagai faktor. Ada dua faktor yang merupakan penyebab langsung terjadinya masalah gizi pada anak, yaitu konsumsi makanan bergizi yang tidak cukup dan kejadian penyakit infeksi atau keduanya.
- Faktor apa pun yang berpengaruh terhadap kecukupan konsumsi dan berpengaruh terhadap kejadian infeksi, akan sangat berpengaruh terhadap status gizi

- **Contohnya:**

Pengasuhan yang kurang tepat karena ketidaktahuan ibu/orang tua pengasuh tentang pemenuhan gizi, tentang kebersihan lingkungan, tentang peran imunisasi dalam mencegah penyakit infeksi, yang disebabkan karena situasi sosial ekonomi yang tidak mendukung dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap status gizi



Pola Asuh bisa diartikan sebagai cara orang tua atau pengasuh merawat, mendidik dan membimbing anak agar sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bagaimana Pola Asuh yang baik?

Kader harus tahu pola asuh yang baik sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada ibu/orang tua/pengasuh. **Pola asuh yang baik antara lain:**

Memenuhi gizi yang cukup

Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan yang cepat, sehingga anak memerlukan semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang cukup. Tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi lengkap. Jadi, anak harus mendapatkan makanan beragam seperti nasi, sayur, buah, kacang-kacangan dan terutama sumber protein dari pangan hewani

Pastikan asupan harian anak **mengandung zat gizi lengkap, beragam, dan cukup jumlahnya**. Makanan yang cukup jumlahnya, memenuhi kebutuhan zat gizi anak untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya

Menjaga kesehatan anak

Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap yang dianjurkan. Imunisasi merupakan cara agar anak tidak menderita berbagai penyakit serius, seperti: infeksi paru-paru (pneumonia), diphteria, batuk rejan, tetanus, dan diare berat.

Jagalah kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan penyiapan makanan anak. Bila sakit segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Mengasuh dengan responsif

Mengasuh dengan responsif berarti orang tua cepat dan peka dalam merespon kebutuhan anak dengan **mengenalinya secara tepat kebutuhan emosi, isyarat yang disampaikan oleh anak melalui suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh.**

Salah satu contohnya adalah:

- Ketika ibu/orang tua/pengasuh memberikan makan kepada anak secara teratur (makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 18),
- Memberlakukan jadwal makan berarti sekaligus melakukan pembiasaan dengan tetap memperhatikan tanda lapar pada anak, sehingga tahu kapan waktu yang tepat untuk makan (pengenalan tanda lapar)
- Melakukan komunikasi

Menjamin keamanan dan keselamatan anak

Orang tua/pengasuh harus menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak bebas dari bahaya. **Pengasuhan yang penuh kasih sayang** akan membuat anak merasa nyaman, aman dan terlindungi.

Contohnya:

- Memastikan anak jauh dari situasi atau barang berbahaya seperti kompor, barang tajam (pisau, gunting dan garpu, kaca), obat, air panas.
- Juga memastikan anak jauh dari situasi bahaya seperti lingkungan di pinggir sungai, sumur, colokan listrik, dll

Memberikan kesempatan belajar sejak dini

Ibu/orang tua/pengasuh memberikan **stimulasi/rangsangan** kepada anak sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan untuk menunjang perkembangan optimal anak.

Contohnya:

- Mengajak bicara saat menyusui atau memberi makan
- Ibu bersenandung/bernyanyi
- Ibu mengajak bermain dengan mengenalkan warna
- Ibu mengajak bermain dengan mengenalkan barang-barang, dan lain-lain

Kader harus **memahami berbagai penyebab masalah gizi** sehingga kader dapat memperkirakan penyebab masalah gizi pada balita, kader berempati dan dapat menawarkan pilihan cara mengatasi masalah kepada ibu/orang tua/ pengasuh

Kader mengumpulkan informasi terkait penyebab masalah gizi yang sering dan mungkin terjadi di wilayahnya. Informasi tersebut digunakan oleh kader ketika mengkaji permasalahan gizi dan kesehatan pada sasaran

Langkah yang perlu dilakukan kader untuk mengidentifikasi penyebab masalah gizi yang terjadi antara lain:

- a. Kader mengisi tabel bantu ceklis penyebab masalah gizi pada balita
- b. Kader memilih penyebab masalah gizi yang paling mungkin terjadi pada seorang balita
- c. Kader membantu penanganan penyebab masalah gizi dengan berkoordinasi pada pihak terkait (desa, puskesmas, PKK, dan lain-lain)

Tabel bantu Ceklis Penyebab Masalah Gizi dan Kesehatan pada Balita

No	Penyebab Masalah Gizi	Ya	Tidak
1	Asupan makan anak kurang, jumlahnya tidak cukup (sedikit) dan atau jarang		
2	Anak sering sakit		
3	Ibu/orang tua/pengasuh belum tahu terkait informasi cara perawatan, pemenuhan gizi dan pencegahan penyakit dalam Buku KIA		
4	Ibu/orang tua/pengasuh tidak memberikan/belum lengkap imunisasinya		
5	Ibu/orang tua/pengasuh tidak memahami pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan		
6	Puskesmas jauh dari rumah		
7	Lingkungan rumah banyak sampah/genangan air/sampah lainnya		
8	Mitos terkait makanan anak (misalnya: balita dilarang mengonsumsi ikan agar tidak berbau amis, dll)		
9	Alergi Makanan		
10	Kondisi ekonomi keluarga balita		
11	Dan lain-lain, sebutkan:		

*) Ceklis Penyebab Masalah Gizi pada Balita

*) Ceklis ini membantu kader mengetahui penyebab masalah gizi yang terjadi pada balita

Masalah gizi pada balita harus dicegah!



Cara mencegah masalah gizi, antara lain:

- **Memastikan ibu hamil sehat** (rutin periksa kehamilan minimal 8 kali selama kehamilan, mengonsumsi TTD/MMS sesuai anjuran) dan status gizinya baik (kenaikan berat badan sesuai dengan usia kehamilannya)
- Memastikan bayi mendapat **ASI eksklusif 6 bulan**
- Memastikan pemberian **MP ASI kaya protein hewani** mulai usia 6 bulan
- Memastikan **pemberian ASI dilanjutkan** sampai usia 2 tahun dengan MP ASI yang cukup
- Memastikan **balita rutin ke posyandu setiap bulan** untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan segera ditindaklanjuti
- Memastikan **imunisasi sesuai jadwal**
- Memastikan pemberian vitamin A dan obat cacing **sesuai jadwal**
- Memastikan **segera ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika anak sakit**
- Memastikan remaja **putri mengonsumsi TTD dan berperilaku gizi seimbang** untuk mencegah anemia, kurang energi kronis (KEK), atau masalah gizi dan kesehatan lainnya
- Memastikan **kebersihan** individu, rumah dan lingkungan

Upaya pencegahan harus terus menerus dilakukan sebelum masalah gizi terjadi, agar segera tertangani dan tidak menjadi semakin berat

Upaya perbaikan tersebut salah satunya dilakukan melalui **Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal Pemulihan**

PMT lokal pemulihan bagi balita bermasalah gizi (T, berat badan kurang, gizi kurang) merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting



Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT Pemulihan)

adalah makanan tambahan berbahan pangan lokal yang **diberikan pada balita bermasalah gizi (balita T, berat badan kurang, gizi kurang)** bertujuan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi balita bermasalah gizi agar masalah gizi tidak semakin berat (gizi buruk dengan atau tanpa stunting) dan memulihkan status gizi balita



Selain untuk pemulihan. PMT juga diberikan sebagai penyuluhan yang disebut sebagai **PMT penyuluhan**

Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT Penyuluhan) adalah makanan tambahan berbahan pangan lokal yang **diberikan pada semua semua sasaran balita saat datang ke Posyandu, dengan tujuan untuk penyuluhan/edukasi**, memberikan contoh makanan utama ataupun selingan (kudapan) yang baik sesuai gizi seimbang.

Berikut ini perbedaan antara PMT Pemulihan dan PMT Penyuluhan Kader wajib tahu!

	PMT PEMULIHAN	PMT PENYULUHAN
TUJUAN	Meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi	Sarana edukasi dalam pemberian makanan kepada balita
SASARAN	Balita berat badan tidak naik Balita berat badan kurang Balita gizi kurang	Balita usia 6–59 bulan
FREKUENSI	Setiap hari Balita berat badan tidak naik: 14 hari Balita berat badan kurang: 28 hari Balita gizi kurang: 56 hari	Pemberian 1 kali dalam sebulan pada hari buka Posyandu
PENYELENGGARA	Puskesmas bersama Kader Kesehatan	Kader Posyandu
PEMBIAYAAN	Puskesmas, Pemerintah Daerah, dan Mitra	Swadaya, Dana Desa, dan Mitra
TEMPAT PEMBERIAN	Diantar ke rumah sasaran setiap hari, dijadwalkan makan bersama	Di Posyandu setiap bulan

PMT lokal bagi Balita Bermasalah Gizi adalah PMT Pemulihan

Tujuan PMT bagi Balita Bermasalah Gizi

- Meningkatkan berat badan yang cukup pada balita bermasalah gizi
- Memperbaiki status gizi balita bermasalah gizi sampai menjadi gizi baik

Sasaran PMT bagi Balita Bermasalah Gizi

- Berat badan Tidak Naik dengan BB/U Normal, BB/PB atau BB/TB tidak overweight dengan atau tanpa stunting
- Balita berat badan kurang tanpa wasting dengan atau tanpa stunting
- Balita gizi kurang dengan atau tanpa stunting

Balita dengan Gizi Buruk harus mendapatkan tata laksana khusus, tidak diberikan PMT Pemulihan.

Bila menemukan kasus Gizi Buruk harus segera dirujuk ke Puskesmas

MENGENAL BALITA BERMASALAH GIZI



Kader harus tahu cara mengenali balita bermasalah gizi

1. Balita Tidak Naik Berat Badannya (1 kali T)

- Timbang berat badan balita (**harus ada 2 data penimbangan berturut – turut**)
- Plotting hasil penimbangan, hubungkan antar titik plotting dan interpretasikan

Balita tidak naik berat badanya meliputi:

a. Naik Tidak Cukup:

Apabila ada kenaikan berat badan, tetapi kenaikannya tidak cukup (arah garis pertumbuhan menjauh (**tidak mengikuti garis pertumbuhan normal**))

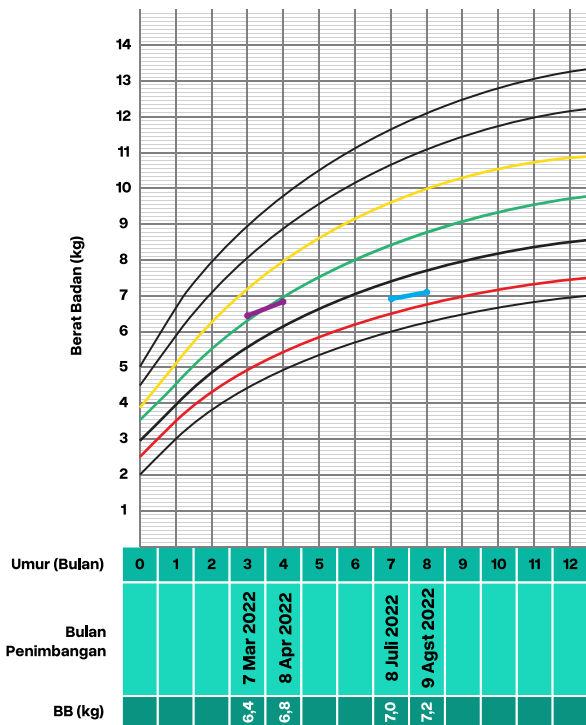
b. Tetap:

Apabila tidak ada kenaikan berat badan (**garis pertumbuhan mendatar**)

c. Turun:

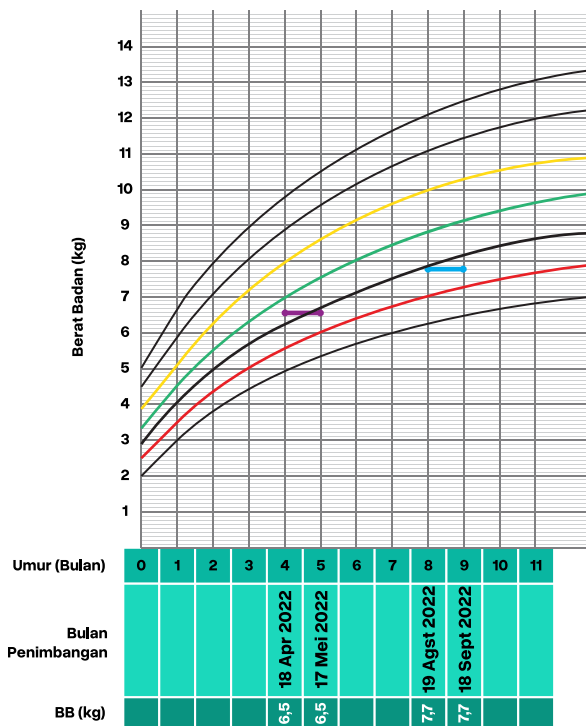
Apabila ada penurunan berat badan (**garis pertumbuhan memotong garis dibawahnya**)

a. BB Naik Tidak Cukup



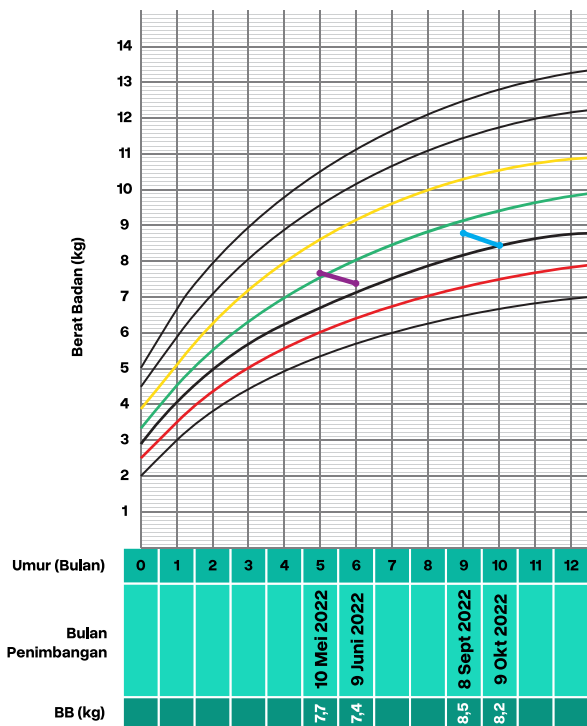
- Hasil penimbangan berat badan (BB) **naik sedikit/naik tidak cukup** dibanding berat badan bulan sebelumnya
- Garis pertumbuhan **tidak mengikuti arah pertumbuhan normal**

b. BB Tetap



- Hasil penimbangan berat badan (BB) **sama dengan berat badan** sebelumnya (tetap)
- Arah **garis pertumbuhan mendatar**

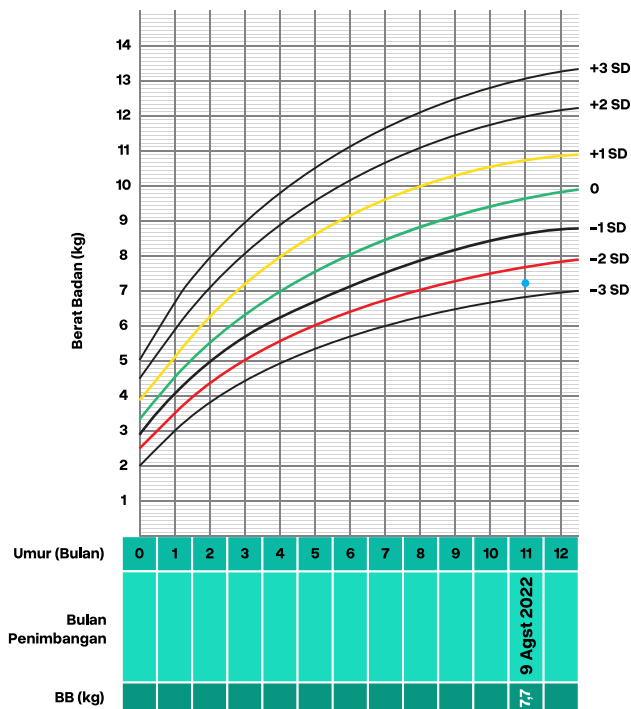
c. BB Turun



- Hasil penimbangan berat badan (BB) lebih **rendah/turun** dibanding dengan berat badan bulan sebelumnya
- Arah garis pertumbuhan **mendatar**

2. Balita berat badan kurang

(Berat badan kurang menurut usianya)

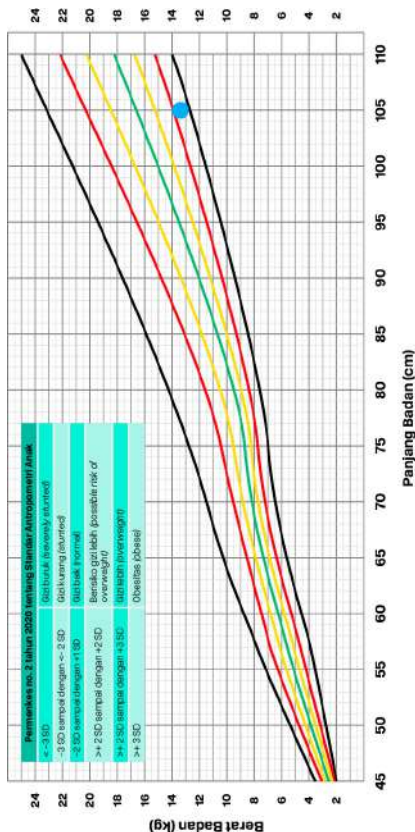


Balita berat badan kurang ditandai dengan garis pertumbuhan di Bawah Garis Merah (BGM)

3. *) Balita gizi kurang

(Berat badan kurang menurut tinggi/panjang badannya)

- Status gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB berada pada z-skor -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD;
- Gizi kurang yaitu status gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB berada pada z-skor -3 Standar Deviasi (SD) sampai dengan >-2 Standar Deviasi (SD)



*) Penilaian Status Gizi dilakukan oleh tenaga kesehatan

Jika pada saat pelaksanaan Posyandu kader menemukan **balita T (1 kali)**, dalam 1 bulan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan **balita dibawah garis merah (BGM)**, kader harus:

- a. **Segera** minta ibu/orang tua/pengasuh datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. **Segera** melaporkan kepada tenaga kesehatan.

Kader membantu agar penanganan oleh tenaga kesehatan jangan sampai terlambat ya!

POSYANDU



Untuk **mengetahui lebih awal** (deteksi dini) terjadinya masalah gizi pada balita juga dapat dilakukan melalui pengukuran Lingkaran Lengan Atas (LiLA)



LiLA pada 6 – 59 bulan

Pengukuran LiLA dilakukan pada usia **6 bulan – 59 bulan**

Pengukuran LiLA dilakukan oleh kader di posyandu setiap bulan **dan atau dapat dilakukan oleh orang tua/pengasuh di rumah secara mandiri**

Pengukuran LiLA sebagai upaya untuk mengetahui lebih awal (deteksi dini) jika ada masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk)

Tata cara pengukuran LiLA dapat mengacu pada Buku KIA



Ayo cegah masalah gizi melalui Pemantauan Pertumbuhan **Rutin Setiap Bulan**



Kepala

Punggung

Pantat

Betis

Tumit



Pemantauan Pertumbuhan

Pemantauan Pertumbuhan

- Pemantauan pertumbuhan dilakukan melalui penimbangan berat badan **rutin setiap bulan** dan pengukuran panjang/tinggi badan, lingkaran kepala dan LiLA. Biasanya dilakukan di Posyandu.
- Pemantauan pertumbuhan bertujuan untuk **mengetahui lebih awal (deteksi dini)** masalah gizi pada balita

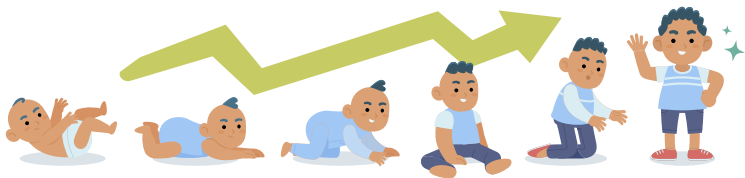
Yang harus dilakukan kader:

- Memastikan **seluruh balita datang ke Posyandu** rutin setiap bulan
- Melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan, lingkaran kepala dan LiLA dengan cara benar
- **Ploting** hasil penimbangan berat badan pada Kartu Menuju Sehat (KMS) sesuai jenis kelamin dan usia pada Buku KIA, dan **menginformasikan hasil plotting penimbangan (Naik/Tidak Naik)**
- **Bersama tenaga kesehatan**, plotting hasil pengukuran panjang/tinggi badan pada Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) sesuai jenis kelamin dan usia pada Buku KIA dan menginformasikan hasilnya kepada orang tua/pengasuh
- **Memotivasi orang tua/pengasuh** selalu melakukan pemantauan pertumbuhan rutin setiap bulan dan edukasi sesuai Buku KIA
- **Menindaklanjuti hasil pemantauan pertumbuhan** terutama jika menemukan balita T dan BGM segera melaporkan kepada tenaga kesehatan

Catatan: plotting (membuat tanda titik “.” pada KMS sesuai dengan usia dan hasil penimbangan serta pengukuran)

Pemantauan Perkembangan

Pemantauan perkembangan tidak kalah penting untuk dilakukan. Pertumbuhan sejalan dengan perkembangan. Jika terjadi masalah pertumbuhan, biasanya perkembangan balita akan ikut terpengaruh. Memberikan stimulasi perkembangan sangat penting untuk menjamin perkembangan balita optimal.



Kader harus tahu cara melakukan pemantauan perkembangan:

1. Kader membantu ibu/orang tua/pengasuh untuk mengisi **ceklis perkembangan sesuai usia dalam Buku KIA**
2. Kader membantu ibu/orang tua/pengasuh mendapatkan informasi terkait stimulasi perkembangan sesuai yang tercantum dalam Buku KIA
3. Kader memotivasi ibu/orang tua/pengasuh untuk menemui tenaga kesehatan saat balita dan anak prasekolah usia 6, 9, 18, 24, 36, 48, 60, 72 bulan untuk mendapatkan skrining perkembangan dengan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan



**Omelette Mie
Telur dan Ayam**



Tahu Isi Telur

PMT LOKAL BAGI BALITA BERMASALAH GIZI



**Soto Ayam
dan Telur**



**Sop Ayam
Telur**

Lama Waktu Pemberian

PMT lokal pemulihan **diberikan setiap hari** dengan lama pemberian sebagai berikut:

Balita bermasalah gizi	Lama waktu pemberian
Balita T	14 hari
Balita berat badan kurang	28 hari
Balita gizi kurang	56 hari

- dengan PMT lokal pemulihan selama 14 hari, **balita T akan naik cukup berat badannya** sehingga garis pertumbuhannya sesuai pertumbuhan normal
- dengan PMT lokal pemulihan selama 28 hari, **balita berat badan kurang akan menjadi balita berat badan normal**
- dengan PMT lokal pemulihan selama 56 hari, **balita gizi kurang akan menjadi balita gizi baik**

Jika belum ada kenaikan berat badan dan perbaikan status gizi maka PMT perlu dievaluasi

Prinsip PMT lokal bagi Balita Bermasalah Gizi

- Berupa **makanan siap saji** dalam bentuk **makanan lengkap atau kudapan/selangan, kaya protein hewani** dengan memperhatikan gizi seimbang
- Dalam satu kali makan **terdiri dari 2 (dua) macam bahan makanan sumber protein hewani** yang berbeda. Tujuannya agar menu kaya protein hewani dan mendapatkan asam amino yang lengkap.

Contoh:

Menggunakan telur dan ikan atau telur dan ayam atau telur dan daging atau ikan dan ayam

Catatan:

- Makanan siap saji adalah makanan yang disiapkan/dimasak di rumah tangga dari bahan pangan lokal yang segar. Bukan makanan kemasan dari pabrik atau yang diawetkan.

Contoh:

kudapan barongko pisang telur, sosis solo isi ayam

- Menggunakan bahan pangan dan cara pengolahan yang halal



Barongko
Pisang Telur



Sosis Solo
Isi Ayam

- Makanan tambahan **terbuat dari pangan lokal yang mudah didapat. Sumber pangan yang digunakan beragam/bervariasi**, terdiri dari pangan sumber makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah.
- **Menghindari makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula dan bahan berbahaya** (pengawet, pewarna, perasa tambahan, pemanis buatan), seperti susu dengan tambahan gula, berperisa dan kental manis.
- Pemberian makanan tambahan **disertai pesan atau edukasi**.

PMT lokal adalah tambahan asupan, bukan pengganti makanan utama sehari-hari

Balita tetap mendapat makanan utama sehari-hari (makanan lengkap 3–4 kali sehari dan makanan selingan 2–3 kali sehari) oleh ibu/orang tua/pengasuh untuk memenuhi kebutuhan asupan gizinya.



Pentingnya Makanan Tambahan dari Bahan Pangan Lokal

- Bahan pangan mudah diperoleh
- Bahan makanan lebih murah/ekonomis
- Variasi makanan dapat diupayakan lebih banyak
- Variasi makanan mencegah kebosanan, meningkatkan kepatuhan konsumsi
- Memberdayakan masyarakat sekitar (petani, peternak, pedagang lokal)
- Bahan alami dari pangan lokal lebih sehat dan bergizi tinggi (mudah diserap oleh tubuh) dibanding makanan kemasan/pabrikan yang mengalami proses pengolahan berkali-kali

Pangan Lokal sebagai Sumber Zat Gizi



Bahaya Makanan Kemasan/Pabrikan

- Tinggi gula



- Tinggi garam



- Tinggi lemak jenuh



- Mengandung zat pengawet, pewarna



- Tidak beragam (cenderung tidak bervariasi)

- Biasanya rendah zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan (rendah protein)



- Mengalami proses pengolahan berkali-kali kehilangan zat gizi alaminya



Kader harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan Puskesmas, jika kader mendapat bantuan berupa makanan kemasan/pabrikan maupun berupa susu (produk pengganti ASI) dari Perusahaan/pihak lainnya, untuk digunakan pada kegiatan Posyandu (baik untuk PMT pemulihan maupun PMT penyuluhan).

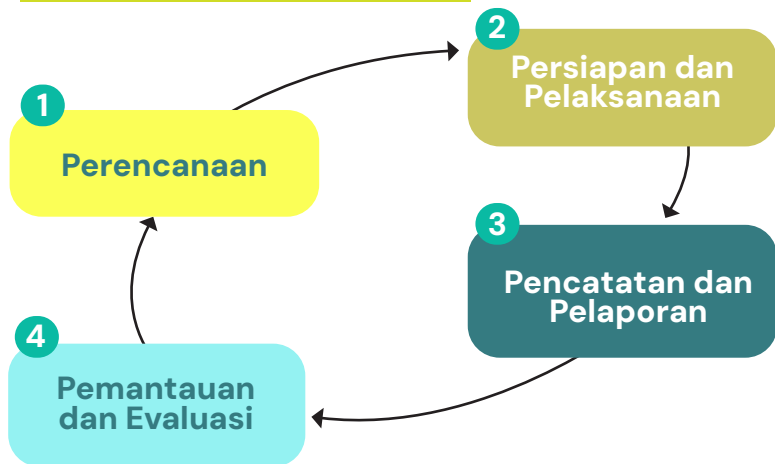


Puskesmas harus mengetahui jika ada bantuan Makanan dan minuman untuk balita (termasuk untuk balita bermasalah gizi)

KEGIATAN KADER DALAM PELAKSANAAN PMT LOKAL



Peran Kader dalam Pelaksanaan PMT Lokal



1. Peran Kader pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan kader **bekerja sama dengan tenaga kesehatan puskesmas**, dalam melaksanakan perannya antara lain:

- Menghitung jumlah sasaran balita sasaran PMT lokal pemulihan
- Melakukan pengecekan sasaran PMT lokal pemulihan
- Menetapkan lokasi pelaksanaan PMT lokal pemulihan berdasarkan sebaran sasaran
- Merencanakan menu (siklus menu) dalam kurun waktu pelaksanaan PMT lokal pemulihan



- Menghitung kebutuhan anggaran untuk memasak menu makanan tambahan sesuai siklusnya
- Merencanakan materi edukasi (penyuluhan dan demonstrasi)
- Merencanakan pembagian tugas kader

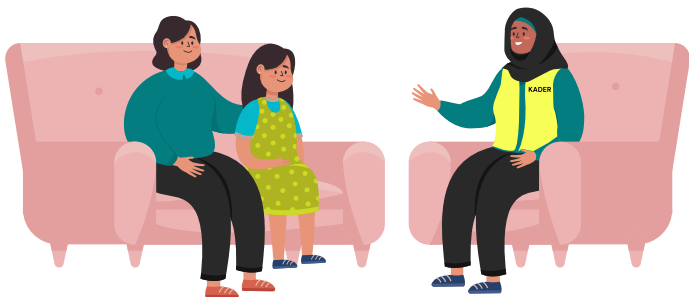
A. Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Menghitung Jumlah Sasaran PMT Lokal Pemulihan

Tenaga Kesehatan mengambil data sasaran dari Sigizi Kesga, selanjutnya bersama kader:

- Mengelompokkan sasaran berdasarkan masalah gizinya (berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang) dan usia (6–8 bulan, 9–11 bulan, 12–23 bulan, $\geq$ 24 bulan)
- Menghitung jumlah sasaran yang akan mendapatkan PMT lokal pemulihan berdasarkan masalah gizi dan usia
- Melaporkan kepada tenaga kesehatan jika ada sasaran baru yang ditemukan di posyandu atau di wilayah kerja



B. Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Melakukan Verifikasi Sasaran PMT Lokal Pemulihan



Setelah tenaga kesehatan menetapkan balita yang menjadi sasaran PMT lokal pemulihan, kader membantu tenaga kesehatan dalam verifikasi data sasaran.

Cek keberadaan sasaran di lokasi

Memastikan kesediaan orang tua/pengasuh balita menjadi sasaran PMT lokal Pemulihan

C.

Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Menetapkan Lokasi Pelaksanaan PMT lokal

Lokasi pelaksanaan PMT pemulihan ditetapkan berdasarkan sebaran data sasaran. Kader Bersama tenaga kesehatan:

Memetakan sebaran sasaran

Memetakan sumber daya (sarana dan prasarana) yang ada di lapangan

Berkoordinasi dengan perangkat desa/ kelurahan, PKK/dasa wisma, pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasarana

Menetapkan lokasi penyelenggaraan PMT lokal pemulihan atau menetapkan lokasi droping untuk distribusi

D. Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Menyusun Menu (Siklus Menu) PMT Lokal Pemulihan

Siklus menu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik sasaran dan ketersediaan bahan pangan lokal setempat, serta kapasitas pengolahan, dll).

- Menyusun siklus menu, divariasikan sesuai kearifan lokal (bahan pangan yang tersedia/musim)
- Dapat menggunakan siklus menu 7 hari + 1 atau 10 hari + 1 untuk menghindari kebosanan
- Semakin lama durasi siklus menu, semakin dapat menghindari kebosanan dari sasaran
- Penting untuk memperhatikan pemorsian PMT lokal yang akan diberikan kepada sasaran sesuai dengan usianya, agar kandungannya sesuai dengan standar kalori (energi), protein, lemak, vitamin dan mineral.
- Siklus menu dapat dirubah jika ada keluhan dari sasaran (misal: bosan, alergi, dan lain-lain)

E. Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Menghitung Kebutuhan Anggaran



Kebutuhan anggaran disusun berdasarkan jumlah sasaran dan siklus menu.

Memetakan kebutuhan anggaran belanja bahan termasuk kebutuhan operasionalnya untuk setiap menu



Menghitung kebutuhan total anggaran belanja bahan dalam satu kali siklus menu

F. Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Merencanakan Materi Edukasi

Edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan secara berkelompok atau konseling perorangan

Membuat daftar materi yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran (usia, penyebab masalah gizi) dan masalah utama di suatu wilayah



Menyiapkan media edukasi yang dapat digunakan (Buku KIA)

Menyusun jadwal edukasi beserta materinya



G.

Kader Bekerja Sama dengan Tenaga Kesehatan untuk Pembagian Tugas Kader

Penyelenggaraan PMT lokal dilakukan oleh semua kader dalam wilayah Puskesmas. Untuk menghindari beban kerja yang berat, dilakukan pembagian tugas

Memetakan tim kader yang akan terlibat dalam penyelenggaraan PMT lokal pemulihan

Memetakan tugas kader dalam penyelenggaraan PMT lokal

Membuat jadwal dan pembagian tugas kader

No	Tugas	Oleh
1	Pendataan sasaran	(tuliskan nama)
2	Belanja bahan kering	...
3	Belanja bahan basah	...
4	Memasak	...
5	Mengantar PMT	...
6	Pemantauan harian, mingguan, bulanan	...

2. Peran Kader pada Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan kader **bekerja sama dengan tenaga kesehatan puskesmas**, dalam melaksanakan perannya antara lain:

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengolahan makanan (alat masak, alat penyimpanan bahan makanan, dll

Memastikan personel kader dan personel lainnya yang akan bertugas dalam jangka waktu dekat

Memetakan bahan makanan yang akan dibeli sesuai siklus menu

Melakukan pembelian bahan makanan

Melakukan koordinasi terkait distribusi makanan tambahan



3. Peran Kader pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kader **bekerja sama dengan tenaga kesehatan puskesmas**, dalam melaksanakan perannya antara lain:

Melakukan pengolahan makanan tambahan sesuai prinsip keamanan pangan

Melakukan pemorsian sesuai usia sasaran

Melakukan distribusi makan tambahan ke rumah sasaran

Memberikan edukasi kepada ibu/ pengasuh balita secara sederhana (menggunakan Buku KIA)

Melakukan demonstrasi pengolahan makanan tambahan secara berkala sebagai bagian dari edukasi

Memastikan komitmen baik dari orang tua/ pengasuh (konsumsi makanan harian baik, dan MT pemulihan dihabiskan)



**Yang harus diperhatikan kader pada Pada Tahap
Persiapan, Pengolahan dan Distribusi PMT lokal
pemulihan:**

5 Kunci Keamanan Pangan



Jaga kebersihan (cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah)



Pisahkan pangan mentah dan matang
(memisahkan tempat penyimpanan dan peralatan yang digunakan untuk bahan makanan mentah dan matang)



Memasak dengan benar dan matang
(terutama bahan makanan protein hewani)



Jaga pangan pada suhu aman (penyimpanan pangan aman pada suhu dibawah 5° Celcius atau diatas 60° Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri)



Gunakan air dan bahan baku yang aman

A. Kader Memahami Cara Pengolahan PMT Lokal yang Aman



MEREBUS

- Menggunakan air bersih secukupnya
- Merebus sampai semua bahan terendam
- Merebus sampai tingkat kematangan tertentu



MENGUKUS

- Menggunakan air bersih secukupnya
- Mengukus sampai tingkat kematangan tertentu



MENUMIS

- Memasak makanan dalam dengan minyak sedikit
- Memanaskan minyak sebelum bahan dimasukkan
- Menumis dengan waktu yang singkat



MEMANGGANG

- Memanggang dapat menggunakan wajan dengan alas daun
- Memanggang sampai tingkat kematangan tertentu
- Hindari sampai terbakar hangus

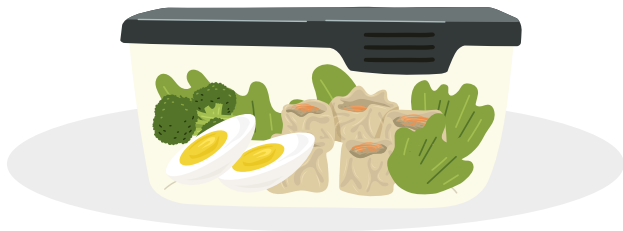


MENGGORENG

- Menggunakan minyak goreng secukupnya
- Memanaskan minyak goreng sampai suhu tertentu sebelum bahan dimasukkan
- Menggoreng sampai tingkat kematangan tertentu
- Agar minyak goreng tidak digunakan setelah 2 kali pemakaian

B. Tips Aman dalam Penyediaan PMT Lokal

- Masak dalam jumlah kecil, sesuaikan dengan alat masak yang tersedia
- Masak makanan lengkap dan atau kudapan/selingan 1-2 jam sebelum disajikan
- Segera diantar ke sasaran PMT lokal pemulihan **agar dapat segera dikonsumsi** dalam 1-2 jam setelah selesai dimasak, untuk menghindari makanan basi dan tercemar oleh bakteri
- Menggunakan wadah bersih dan tertutup dan diberikan **label yang ditulis maksimal waktu makanan dapat dikonsumsi**
- Usahakan makanan dikonsumsi dalam waktu 1-2 jam setelah diterima **agar makanan tidak basi**



Catatan: distribusi disarankan dapat menggunakan tas thermal

4. Peran Kader pada Tahap Pencatatan dan Pelaporan

Pada tahap pencatatan dan pelaporan kader **berkoordinasi dengan tenaga kesehatan puskesmas**, dalam melaksanakan perannya antara lain:

Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan harian

Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan mingguan

Mencatat dan melaporkan sasaran *drop out*

Mencatat dan melaporkan jika ada kejadian luar biasa (keracunan, wabah penyakit yang berpengaruh pada kesehatan dan status gizi) yang dialami balita pada kurun waktu pemberian makanan tambahan



A. Kader Melakukan Pemantauan Harian

Pemantauan harian dilakukan setiap hari. Dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui whatsapps, telepon, dll)

- Kader menanyakan kondisi kesehatan balita (sehat/sakit)
- Kader menanyakan tanda bahaya yang mungkin ada saat balita sakit (Ada/tidak tanda bahaya, mengacu Buku KIA)
- Kader menanyakan apakah makanan tambahan dikonsumsi atau tidak beserta alasannya (tidak suka menyusu/rasanya, porsi terlalu besar, dll)
- Kader menanyakan kepatuhan konsumsi harian balita (3 kali makanan utama dan 2 kali makan selingan), apakah makanan tambahan menggantikan makanan utama
- Kader mengisi hasil pemantauan harian pada formulir pemantauan

Rujuk sekarang jika menemukan tanda bahaya pada balita yang sakit (diare, muntah, demam, kejang, dll mengacu pada Buku KIA)

Formulir Pemantauan Harian

Cara mengisi Formulir Pemantauan Harian:

1. Tulis nama balita dengan lengkap dan jelas
2. Tulis nama ibu dengan jelas
3. Tulis Tanggal, bulan dan tahun lahir balita dengan jelas
4. Tulis Alamat lengkap: nama jalan, no rumah RT /RW/Dusun, nama desa
5. Isi kolom hari, tanggal/bulan/tahun pemberian MT
6. Pada kolom keterangan PMT, **beri tanda (V)** pada kolom yang sesuai jika PMT **dimakan habis atau tidak**
7. Pada kolom kondisi kesehatan, beri tanda (V) pada kolom yang sesuai jika **anak sehat atau tidak**
8. Jika ada sedang dalam kondisi tidak sehat, tuliskan sakitnya, misalnya: demam, batuk, pilek, dll

Selain melakukan pemantauan harian untuk mengetahui apakah PMT pemulihan dihabiskan atau tidak dan kondisi kesehatan balita (sakit/sehat), **kader harus memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak menggantikan makanan utama yang harus dikonsumsi balita.**





Oleh karena itu **penting untuk mencatat kepatuhan konsumsi balita** terhadap makanan utamanya (3–4 kali makanan lengkap dan 2–3 kali makanan selingan)

Mengisi Formulir Penilaian Konsumsi Makan Sehari-hari pada Sasaran Balita

1. Pada kolom hari tanggal diisi dengan nama hari dan tanggal saat PMT lokal pemulihan pertama kali diberikan
2. Beri tanda (V) pada kolom makan pagi jika balita menghabiskan makanannya atau tidak
3. Beri tanda (V) pada kolom snack pagi jika balita menghabiskan makanannya atau tidak
4. Beri tanda (V) pada kolom makan siang jika balita menghabiskan makanannya atau tidak
5. Beri tanda (V) pada kolom snack siang jika balita menghabiskan makanannya atau tidak
6. Beri tanda (V) pada kolom makan malam jika balita menghabiskan makanannya atau tidak

Pemantauan Harian: Kartu kontrol penilaian kepatuhan konsumsi makan sehari-hari balita bermasalah gizi

Nama Balita :
Nama Ibu :

Tanggal, Bulan, Tahun lahir balita :
Alamat :

Hari, Tanggal	Hari !	Makan pagi		Snack pagi		Makan siang		Snack siang		Makan malam	
		Habis	Tidak	Habis	Tidak	Habis	Tidak	Habis	Tidak	Habis	Tidak
Senin, 23 Mei 2025	1		V		V		V		V		V
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
dst	13										

Catat hasil penimbangan Berat Badan (BB) dan pengukuran Panjang Badan (PB) atau Tinggi Badan (TB) dalam kolom yang disediakan.

*Pengisian hasil pemantauan kesehatan dengan memberikan tanda centang (V) pada kolom yang sesuai dengan hasil pemeriksaan

B. Kader Melakukan Pemantauan Mingguan

Pemantauan mingguan dilakukan setiap minggu untuk memantau kenaikan berat badan balita

Kader melakukan penimbangan berat badan dengan alat dan tata cara terstandar

Kader mencatat hasil penimbangan berat badan pada formulir pemantauan mingguan



Kader meneginformasikan hasil pemantauan mingguan kepada ibu/orang tua/pengasuh dan mendiskusikan hasilnya dengan tenaga kesehatan



Rujuk sekarang jika menemukan tanda bahaya pada balita yang sakit (diare, muntah, demam, kejang, dll mengacu Buku KIA)

Formulir Pemantauan Mingguan

Cara mengisi Formulir Pemantauan Mingguan (1):

Pada bagian atas formulir pemantauan bulanan, tuliskan:

1. Tuliskan **nama lengkap balita**
2. Tuliskan **nama lengkap ibu balita**
3. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun lahir balita
4. Tuliskan berat badan balita saat dilakukan pemantauan berat badan pertama kali (dalam satuan kilogram, boleh pakai koma).
5. Tuliskan tinggi badan balita saat dilakukan pemantauan pertama kali (dalam satuan cm)

Pada bagian tabel formulir pemantauan mingguan, tuliskan:

1. Tuliskan hari dan tanggal, bulan, tahun setiap kali dilakukan pemantauan berat badan ibu hami
2. Lingkari pemantauan yang dilakukan merupakan pemantauan minggu ke berapa. Contoh jika hari ini merupakan pemantauan pertama kali, maka lingkari pemantauan minggu ke 1, jika hari ini pemantauan minggu ke 3 maka lingkari pelantauan minggu ke tiga, penulisan hari, tanggal dan ukuran berat bada dicantumkan pada baris yang sama

Cara mengisi Formulir Pemantauan Mingguan (2):

Pada bagian tabel formulir pemantauan mingguan, tuliskan:

1. Tuliskan berat badan balita berdasarkan hasil pengukuran berat badan oleh kader. Tuliskan berat badan dalam satuan kilogram.
Contoh : 8,5 kg; 10,2 kg; 11,4 kg
2. Bandingkan hasil berat badan saat ini dengan berat badan pada pengukuran sebelumnya.
3. Apabila berat badan saat ini naik dari berat badan sebelumnya, maka tuliskan N pada kolom Kesimpulan
4. Apabila berat badan saat ini tetap atau berkurang dari berat badan sebelumnya, maka tuliskan T pada kolom Kesimpulan
5. Jika pemantauan merupakan pemantauan ke 2, 4, 6, 8 dst, maka ukur tinggi badan balita, tuliskan hasil pengukuran tinggi badan balita dalam satuan centimeter pada kolom Panjang badan/ tinggi badan
6. Kolom hasil konfirmasi nakes dan kolom pemantauan kesehatan (terkait red flag) akan diisi oleh tenaga kesehatan

Pemantauan Mingguan: Pemantauan Berat Badan (BB) dan Panjang Badan/Tinggi Badan (PB/TB) Balita

Pemantauan Berat Badan dan Panjang Badan/Tinggi Badan Balita serta Pemantauan Kesehatan Balita

Nama Balita		Berat Badan Awal	kg
Nama Ibu			
Tgl. bulan, tahun lahir		Panjang/Tinggi Badan Awal	cm

Hari, tanggal	Pemantauan Minggu ke-	Berat Badan (BB)		Kesimpulan Naik (N)/ Tidak Naik (T)	Panjang Badan (PB)/ Tinggi Badan (TB)		Pemantauan Kesehatan*	
		Hasil Pengukuran Kader	Hasil Konfirmasi Nakes		Hasil Pengukuran Kader	Hasil Konfirmasi Nakes	Tidak Ada Red Flag/ Penyakit	Ada Red Flag/ Penyakit
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	dst.							

Catat hasil penimbangan Berat Badan (BB) dan pengukuran Panjang Badan (PB) atau Tinggi Badan (TB) dalam kolom yang disediakan.

*Pengisian hasil pemantauan kesehatan dengan memberikan tanda centang (V) pada kolom yang sesuai dengan hasil pemeriksaan

C. Kader Melaporkan Hasil Pemantauan Kepada Tenaga Kesehatan

Kader melaporkan hasil pemantauan kepada tenaga kesehatan melalui formulir pemantauan harian dan mingguan yang sudah terisi

1. Kader mengumpulkan formulir pemantauan harian yang sudah terisi kepada tenaga kesehatan
2. Kader mengumpulkan formulir pemantauan mingguan yang sudah terisi kepada tenaga kesehatan
3. Tenaga kesehatan melakukan kajian terhadap hasil pemantauan harian dan mingguan
4. Tenaga kesehatan menginformasikan hasil kajian pemantauan harian dan mingguan baik kepada kader maupun kepada ibu/orang tua/pengasuh
5. Kader melakukan tindak lanjut sesuai arahan tenaga kesehatan

5. Peran Kader pada Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap pemantauan dan evaluasi kader **melakukan**:



Pemantauan harian

*) Pemantauan mingguan

Melaporkan hasil pemantauan
kepada tenaga kesehatan

*) Pada pemantauan mingguan, sebaiknya kader didampingi oleh tenaga kesehatan

Sasaran Gagal/Drop Out

- Orang tua/keluarga menolak/mengundurkan diri
- Sasaran tidak mendapatkan PMT berbahan pangan lokal selama 7 (tujuh) hari berturut-turut (misalnya pergi ke luar daerah, pindah domisili, dll)
- Sasaran sakit dan dirawat di RS (perlu mendapatkan tata laksana lain)
- Sasaran meninggal

Mencegah Sasaran Gagal/Drop Out

- Sebelum PMT lokal dimulai, kader memberikan informasi terkait tujuan dan manfaat PMT lokal
- Sebelum PMT lokal dimulai kader memastikan kesediaan orang tua/pengasuh
- Selama pelaksanaan kader terus menerus memberikan motivasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat PMT lokal pemulihan bagi balita
- Kader bertindak cepat dan tepat terhadap semua keluhan sasaran (rasa makanan), menu disukai atau tidak
- Kader bersama tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait segera menindaklanjuti keluhan orang tua/pengasuh
- Kader memberikan pujian kepada orang tua/pengasuh

Penyediaan PMT Lokal Pemulihan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

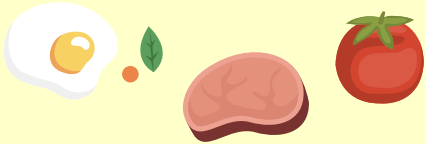
Puskesmas dapat bermitra dengan pihak ketiga dalam penyediaan makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita bermasalah gizi. Pihak ketiga melakukan distribusi makanan tambahan lokal kepada sasaran melalui Kader.

Keuntungan distribusi dilakukan oleh Kader antara lain:

- Kader lebih mengenal sasaran
- Edukasi dapat dilakukan lebih mudah dengan kedekatan pribadi

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian:

- Peran pihak ketiga dilaksanakan melalui koordinasi dengan Puskesmas
- Tugas, wewenang termasuk hak dan kewajiban pihak ketiga dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Sama” antara Puskesmas dengan pihak ketiga
- Pada umumnya tugas pihak ketiga meliputi hal-hal yang terkait penyediaan makanan tambahan yaitu belanja bahan mentah, menyediakan makanan tambahan sesuai menu dan standar yang ditetapkan Puskesmas, mendistribusikan makanan tambahan sampai pada titik tertentu (Puskesmas).
- Pihak ketiga bekerja sama dengan kader dalam distribusi makanan tambahan sampai ke sasaran
- Puskesmas melakukan supervisi secara berkala terhadap pihak ketiga



CONTOH MENU DAN SIKLUS MENU PMT LOKAL



Contoh Menu dan Siklus Menu beserta Kegiatan Edukasi PMT Lokal Pemulihan bagi Balita Bermasalah Gizi

Ilustrasi tidak menunjukkan porsi pemberian

	Edukasi dilaksanakan setiap hari	Menu PMT Lokal pemulihan sesuai siklus menu		Pelaksanaan Demonstrasi Memasak
Hari 1	✓	 Sup kentang, bola daging	 Barongko (dengan telur dan santan)	Mengandung 2 macam protein hewani: daging dan telur
Hari 2	✓	 Kroket telur isi ayam & wortel	 Puding roti (dengan telur)	Mengandung 2 macam protein hewani: ayam dan telur
Hari 3	✓	 Lontong mie isi ayam dan telur puyuh	 Tekwan ikan	Mengandung 2 macam protein hewani: telur puyuh dan ikan
Hari 4	✓	 Talam ubi suwir ikan	 Martabak tahu telur	Mengandung 2 macam protein hewani: ikan dan telur

	Edukasi dilaksanakan setiap hari	Menu PMT Lokal pemulihan sesuai siklus menu		Pelaksanaan Demonstrasi Memasak
Hari 5	✓	 Semar mendem isi ayam	 Makaroni kukus cincang daging	Mengandung 2 macam protein hewani: ikan dan telur
Hari 6	✓	 Mento ayam	 Siomay ikan	Mengandung 2 macam protein hewani: ayam dan ikan
Hari 7	✓	 Nasi ikan kuah kuning	 Perkedel telur kentang	Mengandung 2 macam protein hewani: ikan dan telur

Catatan: (1) Berikut adalah contoh menu untuk balita usia lebih dari 12 bulan. Untuk bayi usia kurang dari 12 bulan, dapat disesuaikan dengan prinsip PMBA, **(2)** setiap menu PMT lokal wajib ada protein hewani

Contoh Resep Nusantara Makanan Padat Gizi



Pliek U hati ayam/
udang &
daun melinjo

ACEH TIMUR



Gangan Manok Hati
Ayam (serta Telur)

KUTAI BARAT



Binte Biluhuta – ikan,
udang

**BARIGI
MOUTONG**



Roti Goreng Isi
Ragout Ayam
Sayuran (serta telur)

LEBAK



Pecel Tumpang &
peyek Rebon, telur

KEDIRI



Nasi Iapola – ikan,
rebon

KEP. ARU



Aunu Senebre – Teri
**MEMBERAMO
TENGAH**

Link Resep Menu PMT Lokal Nusantara



<https://s.kemkes.go.id/ResepMenuPMTLokalNusantara>

EDUKASI PMT LOKAL OLEH KADER BAGI IBU/ ORANG TUA/PENGASUH



Berbagai Cara untuk Melakukan Edukasi/ Penyuluhan Terkait PMT Pemulihan Kepada Ibu/Orang Tua/Pengasuh

Cara penyuluhan yang dapat dilakukan	Tujuan/Manfaat	Waktu Pelaksanaan
 Edukasi Individu	Memberikan informasi/pengetahuan kepada ibu secara perorangan	Lakukan saat kunjungan rumah
 Edukasi kelompok	• Berbagi pengetahuan • Berbagi pengalaman • Berbagi motivasi	Lakukan saat sasaran berkumpul (1 minggu sekali atau 1 bulan sekali)
 Demonstrasi Memasak	Memberikan contoh cara memasak makanan yang bergizi seimbang	Lakukan saat sasaran berkumpul (1 minggu sekali atau 1 bulan sekali)

Contoh Waktu Pelaksanaan Edukasi

Edukasi individu dilakukan saat mengantar PMT dengan pesan sederhana, misalnya:
Cuci tangan ya sebelum makan

Edukasi individu juga dapat dilakukan melalui WhatsApp

Edukasi kelompok dilakukan saat kelas ibu balita atau sesi lainnya saat sasaran bersama

Edukasi juga bisa dilakukan melalui memutar video sederhana yang dibuat oleh kader dengan nakes (misalnya Video cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, video cara memotong sayur, dll)

Pelaksanaan demonstrasi memasak dapat dilakukan dengan dukungan dana desa, CSR/kemitraan, kerja sama dengan institusi pendidikan dan swasta, dll ketika sebulan sekali sasaran PMT lokal berkumpul

Contoh Rencana Materi edukasi oleh Kader kepada Ibu/orang tua/pengasuh terkait PMT Lokal Pemulihan

Minggu Pertama	• Pentingnya Pemantauan pertumbuhan rutin setiap bulan • Manfaat Suplementasi Vitamin A dan pemberian Obat cacing • Manfaat Imunisasi • Pentingnya PMT lokal pemulihan sebagai asupan tambahan
Minggu Kedua	• Cara pemberian MPASI sesuai rekomendasi (PMBA) • Cara perawatan anak sakit • Cara mengolah makanan kaya protein hewani
Minggu Ketiga	• Cara penyiapan dan pengolahan makanan yang bergizi dan aman • Cara Menjaga kebersihan diri dan lingkungan • Cara Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
Minggu Keempat	• Memilih makanan lokal, menghindari makanan kemasan/pabrikan • Stimulasi perkembangan • Pemanfaatan Buku KIA
Minggu berikutnya	Materi edukasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sasaran

Bahan Makanan Sumber Zat Gizi

Makanan Pokok Sumber Karbohidrat



Potato



Sweet Potato



Rice



Singkong



Jagung

Lauk Pauk Sumber Protein Hewani



Ikan Lele



Ayam-Bebek



Beef



Salmon



Otak Sapi



Telur



Hati Ayam



Shrimp

Sumber Protein Nabati



Kacang Kedelai



Kacang Hijau



Kacang Merah



Kacang Tanah



Garbanzo



Edamame



Kacang Mete



Kacang Tolo



Kacang Koro

Sumber Lemak



Sayur dan Buah



Cara membedakan Makanan Asli (makanan yang baik untuk kesehatan) dan Makanan Kemasan/Pabrikan yang diproses berulang kali (makanan yang tidak baik untuk kesehatan)

Makanan Asli (yang dianjurkan)	Makanan Ultra Proses (yang tidak dianjurkan)
Usia 0 – 6 bulan  Air Susu Ibu (ASI)	Usia 0 – 6 bulan  Formula Bayi/Susu Bubuk
Usia 6 bulan – 3 tahun  Protein Hewani dan Protein Nabati  Buah dan Sayur  Bijih-bijian dan kacang-kacangan	Usia 6 bulan – 3 tahun  Formula Bayi dan Sereal Instan  Sarden, Kornet, Sosis, & Nugget  Kudapan Kemasan dan Biskuit

Catatan Kaki:

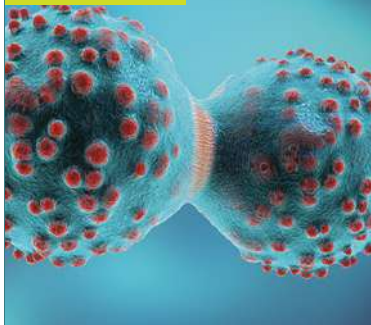
- **Makanan kemasan instan/siap santap dengan banyak bahan tambahan**
- **Definisi:** Produk industri yang sebagian besar atau seluruhnya dibuat dari zat hasil ekstraksi pangan (seperti minyak, pati, isolat protein, gula), hasil turunan pangan, atau bahan sintesis (pewarna, pengawet, pemanis buatan, penguat rasa, emulsifier).
- **Processed:** Makanan yang diubah dari bentuk aslinya, biasanya untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan rasa/keamanan, tetapi masih dapat dikenali bentuk aslinya.

Cara Membedakan Makanan Aseli (makanan yang baik untuk kesehatan) dan Makanan Kemasan/Pabrikan yang Diproses berulang kali (makanan yang tidak baik untuk kesehatan)

Makanan Aseli	Makanan Ultra Proses
Usia 3 tahun – 8 tahun	
 Nasi Goreng	 Ikan Bakar
 Pempek	 Rawon
 Sayur Sop	 Bubur Ayam
 Sate Ayam	 Tongseng Sapi
	 Mie Instan
	 Minuman Kesehatan/energi
	 Minuman Bersoda
	 Roti tawar pabrikan dan makanan beku pabrikan

Risiko Jangka Panjang untuk Kesehatan Akibat Sering Mengonsumsi Makanan Kemasan/Pabrikasi

Kanker



Diabetes



Obesitas



Penyakit Jantung



**CARA KADER
BERKOMUNIKASI
KEPADA IBU/ORANG
TUA/PENGASUH**

Cara berkomunikasi berperan dalam membuat orang tua bersemangat memberi anak PMT Lokal. Bila kurang pas caranya, bisa muncul penolakan. Bila pas, orang tua akan menerima dan mengikuti anjuran dengan senang hati.

Berikut adalah tahapannya



A. Mengobrol akrab

Masalah gizi merupakan masalah sensitif yang dapat membuat orang tua emosi. Karenanya, jangan langsung menyampaikan masalah gizi anak. Coba luangkan waktu untuk mengobrol akrab. Bila sudah akrab, orang tua akan lebih mudah diajak.

Apa tandanya nakes atau kader sudah mulai akrab dengan orang tua?

Di antara tanda-tandanya adalah mengobrolnya sudah nyaman, saling bertanya, tek-tokan, semakin terbuka, dan nonverbalnya atau bahasa tubuhnya pun nyambung alias selaras.

Cara mengobrol agar akrab

1. Jurus Menyebut nama > 5x.

Gunakan nama orang tua yang baru dikenal minimal 5x dalam percakapan. Dengan begitu, nama teringat, dan orang tua pun merasa senang karena dihargai.

Kader : “Sepeda ontel **Bu Rini** cakep nih **Bu Rini**.”
Bu Rini : “Oh, itu hobi suami, Bu Kader.”
Kader : “Hobi sehat, **Bu Rini**. Sudah lama suami **Bu Rini** hobil ontel?”
Bu Rini : “Sejak muda, sebelum kawin.”
Kader : “Wah, langgeng berarti hobinya ya **Bu Rini**?”

Variasi sesuai tradisi lawan bicara:

- Nama anak
- Nama gelar saat dewasa
- Nama marga

2. Kenalkan nama secara menancap.

Saat mengenalkan nama, usahakan agar orang tua mudah menangkap dan menghafal nama kita.

*Perkenalkan, nama saya Juni Juli Agustus. Juli, Ibu Juli nama saya, Bu Rini.
Saya cica-cica di dinding. Seperti lagu, nama saya Bu Cica.*

3. Obrolan informal.

Untuk mengobrol akrab, cari topik yang disukai orang tua. Jangan topik yang kita sukai. Perhatikan sekeliling dan coba dengar-dengar untuk mendapatkan topiknya.

Kader : “Wah, itu foto siapa Pak Edi. Gagah amat!”
Pak Edi : “Oh itu anak saya.”
Kader : “Wah, tugas di mana?”
.....(Pak Edi bercerita tentang tugas anaknya yang tentara, pengalaman seleksi dll.)

4. Nyambung.

Saat orang tua bercerita, nyambunglah dengan bertanya-tanya pendek sehingga orang tua bercerita lebih banyak. Jangan mengganti topik, mematahkan, ataupun mendiamkan.

Bu Titis : "Tapi anak saya lincah, kok. **Suka main.**"

Kader : "Wah, keren. Budi **suka main**, apa sih Bu Titis?"

Bu Titis : "Setiap sore main di **lapangan** sama anak-anak."

Kader : "Oh, di **lapangan** main bola, ya?"

Bu Titis : "Iya, **lincah** banget. Anak-anak kalah lincah."

Kader : "Oh, **lincah** meliuk-liuk?"

Bu Titis : "..." (Cerita lagi)

Contoh Mengganti topik

Bu Titis : "Tapi anak saya lincah, kok. **Suka main.**"

Kader : "Kalau Bu Titis sendiri belanjanya di mana?"

Contoh Mematahkan

Bu Titis : "Tapi anak saya lincah, kok. **Suka main.**"

Kader : "Kalau dalam kondisi kurang sehat, tidak boleh Budi main terlalu cape."

Contoh mendiamkan.

Bu Titis : "Tapi anak saya lincah, kok. **Suka main.**"

Kader : "Oh. Ho-oh ho-oh. Hmm."

Selain nyambung dengan kata-kata (bertanya-tanya pendek), nakes dan kader pun mesti nyambung tanpa kata-kata (nonverbal). Maksudnya, kalau kita mengangguk, orang tua juga ikut mengangguk. Kalau wajah kita serius, wajah orang tua pun ikut serius. Kalau tersenyum, orang tua ikut tersenyum.

Bila orang tua telah nyambung secara tanpa kata-kata, maka dia sedang memperhatikan pesan kita. Bila tidak, maka sebetulnya dia tidak memperhatikan atau jangan-jangan, tengah melawan dalam hati.

Agar orang tua nyambung secara tanpa kata-kata, maka kita yang mesti terlebih dahulu nyambung tanpa kata-kata. Maksudnya, kalau suara orang tua lirih, suara kita pun menyesuaikan lirih. Begitu juga dengan wajah dan senyum.

B. Mengobrol masalah & solusi

Setelah akrab, silahkan kita bisa masuk ke topik masalah gizi. Sampaikan masalah gizi anak secara **tak langsung** tapi dipahami orang tua.

“Bu Eli, timbangan Adi ini kan kurang, ya. Jadi, perlu ditambah timbangannya.”

Agar tak menimbulkan rasa bersalah pada orang tua jelaskan tanpa menyalahkan:

Sebab di luar kontrol. “Bisa juga karena serangan bibit penyakit. Makanan yang kita kasih ke Adi dibuat untuk melawan bibit penyakit. Bukan untuk pertumbuhan. Alhamdulillah, Adi-nya ga sampai sakit.”

Masalah banyak orang tua.

“Iya, banyak bu yang berat badannya kurang.”

“lagi musimnya ini kayanya, ya.”

Netralkan dengan persamaan. “Waktu ngasuh anak pertama, suami pergi ke negeri jiran. Wah, berat ngurus anak sambil kerja. Berat badannya jadi kurleb sama gitu.”

Meringankan solusi. “Tapi biasanya gampang kok naikannya, Bu Ida. Biasanya 2 minggu sudah terlihat hasilnya.

Sebagai solusi, PMT Lokal dikenalkan sebagai makanan sehari-hari sehingga lebih mudah diterima, tetapi kandungan gizinya sudah dihitung dengan rumus khusus oleh para ahli.

“Ini makanan sehari-hari kita, Bu Ida. Adi juga mungkin pernah makan. Memang sengaja dibuat dalam bentuk makanan biasa, supaya Adi tidak kaget. Bedanya, kandungan gizinya sudah dihitung pakai rumus khusus oleh para ahli. Karena memang, kalau mau menambah timbangan dengan pas, ternyata ada rumusnya.”

Pesan tambahan lain

- Khusus untuk anak yang dituju saja, bukan untuk anak lainnya karena sudah dihitung dengan rumus khusus.
- Mesti dihabiskan karena ukurannya sudah dihitung dengan rumus khusus.
- ASI tetap diberikan minimal sampai usia 2 tahun.
- Makanan lain boleh diberikan setelah PMT Lokal dihabiskan.

C. Mengobrol Sepakat

Orang Indonesia mengatakan “mau” atau “iya” bukan berarti “mau” atau “iya” betulan. Acapkali mereka mengatakannya demi sopan santun, menghindari perdebatan atau biar cepat saja.

Karena itu, bila orang tua mengatakan mau memberi makan anak PMT Lokal, tenaga kesehatan atau kader bisa membantu menguatkan komitmen dengan 3 cek.

Cek pengetahuan.

“Saya mau deh PMT Lokalnya, Bu Kader.”

“Supaya?”; “Cara berinya?”

Kalau orang tua bisa menjawab, berarti dia paham karena mengikuti percakapan sungguh-sungguh.

Cek keteguhan.

“Betul mau diberi, Bu Rini? Nanti bosan ngasihnya?”

Cek rincian.

“Rencana kapan memberikannya?”

Kalau orang tua bisa membayangkan aksinya untuk PMT Lokal yang pertama, maka dia lebih dekat dengan realisasi.

Menyegarkan komitmen.

Adakalanya orang tua ingin menghentikan PMT Lokal dengan beragam sebab. Yang perlu dilakukan adalah 1) bertanya agar orang tua menceritakan alasannya, 2) nyambung agar orang tua mau bercerita banyak dan merasa dihargai, 3) sampaikan pesan yang berisi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan/ dicapai dan kebutuhan untuk melanjutkan agar hasilnya lebih bagus.

Pesan apresiasi

“Alhamdulillah, puji syukur sudah ada perkembangan, ya. Ibu Rini sudah berusaha keras menyuapi demi anak. Berat badannya sudah mulai mantap sekarang.”

Pesan kebutuhan melanjutkan PMT Lokal

“Sekarang tinggal menambah X gram lagi (atau berat badan cukup dan tinggal menguatkan kekebalan tubuhnya). Diteruskan lagi saja, Bu Tini. Sampai tuntas, ya.”

PERTANYAAN DAN JAWABAN YANG SERING MUNCUL





**Apakah jus buah yang dibuat sendiri
dianjurkan untuk PMT lokal?**

Tidak dianjurkan. Ganti jus buah dengan makanan/kudapan tinggi protein misalnya pisang barongko dengan telur.



**Barongko
Pisang Telur**



**Sosis Solo
Isi Ayam**



Tahu Isi Telur

Apakah puding dianjurkan digunakan sebagai PMT lokal pemulihan?



Tidak dianjurkan, jika pudding hanya dibuat dengan gula pasir dan air karena menjadi makanan tidak bernilai gizi



Bolehkah memberikan PMT pemulihan berupa biskuit atau roti selai kemasan?

Sebaiknya tidak diberikan, karena biskuit dan roti selai kemasan mempunyai kandungan gula yang tinggi dan zat gizi yang tidak bervariasi

Bolehkah memberikan susu sebagai PMT Pemulihan ?

Susu dan produk olahan susu dapat diberikan sebagai bagian campuran untuk pembuatan makanan tambahan dan harus disesuaikan dengan usia anak.

Susu yang diberikan **tidak boleh** mengandung pemanis buatan, pewarna, perasa (coklat, stroberi, vanila, dll) dan/atau susu tinggi gula (kental manis).

Bolehkah Posyandu menerima dan mendistribusikan bantuan sponsor dalam bentuk susu formula, makanan bayi instan, dan makanan kemasan lainnya?

Tidak boleh, jika ada sponsor sebaiknya diarahkan untuk mendukung pemanfaatan pangan lokal.

Apakah Makanan Tambahan tetap diberikan ketika anak sakit?



Makanan tambahan tetap diberikan ketika anak sakit, dalam porsi kecil dan sering

Makanan tambahan dapat dibuat lebih halus teksturnya

Utamakan protein hewani (habiskan terlebih dahulu)



Apakah ikan teri juga merupakan sumber protein hewani?

Ya, ikan teri merupakan sumber protein hewani yang kaya dengan kalsium yang berguna untuk kesehatan tulang

Apakah madu boleh diberikan pada makanan tambahan anak usia dibawah 1 tahun?

Madu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi anak usia < 12 bulan. Konsumsi madu pada bayi berusia < 12 bulan dapat meningkatkan risiko **infant botulism** (penyakit botulisme pada bayi) akibat toksin yang diproduksi oleh kuman **Clostridium botulinum**. Clostridium botulinum dapat ditemukan juga pada madu.

Gejala yang tampak pada bayi yang mengalami infant botulism antara lain lesu, lemas, sesak napas, malas menyusu, sulit menelan, sembelit, sulit membuka mata, dan mulut kering. Infant botulism **dapat menyebabkan kematian karena kelemahan otot napas.**



Pesan yang Penting



Makanan tambahan
bukan pengganti
makanan utama



Makanan tambahan
untuk **menambahkan**
asupan sehari-hari



Makanan tambahan
mengandung **2 (dua)**
jenis protein hewani yang
penting untuk pertumbuhan



Kader bersama tenaga
kesehatan mempunyai
peran yang penting dalam
mewujudkan generasi emas

5 YA



YA berikan Makanan Tambahan diantara waktu makan utama.



YA utamakan protein hewani tiap kali makan.



YA pilih pangan lokal segar, olah menjadi kudapan padat gizi.



YA catat konsumsi harian dan kondisi balita setiap hari.



YA jaga kebersihan dan keamanan pangan serta lingkungan

Referensi

Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor HK.02.02/B/576/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita Bermasalah Gizi

Bahaya Terselubung dari Ultra Process Food (BPNI, yang diterjemahkan oleh AIMI)

Not only Stunting, caregivers also need to be aware of wasting. Learn more about wasting and stunting, two form of malnutrition that caregivers must know about. Unicef Indonesia, 2023

**Buku Saku Kader
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal
Bagi Balita Bermasalah Gizi**

2025